

## 診療録

## さくら内科クリニック

東京都墨田区錦糸2-14-6 錦糸町メディカルビル3F / TEL 03-5610-8842

診療科：内科 初診  
初診日：令和8年7月2日

|      |                                    |      |                              |
|------|------------------------------------|------|------------------------------|
| 患者氏名 | 田中 美咲 (タナカ ミサキ)                    | 患者ID | SK-0021458                   |
| 生年月日 | 昭和34年8月12日 (66歳)                   | 性別   | 女性                           |
| 住所   | 〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-3 グリーンハイツ402 |      |                              |
| 電話   | 自宅 03-3625-7741 / 携帯 090-2244-6690 | 保険   | 保険者番号 06132014 記号 42 番号 1088 |
| 職業   | パート (調理補助)                         | 緊急連絡 | 長女 090-8123-4471             |

## 主訴

3日前からの発熱 (38°C台) と咳。倦怠感、食思不振あり。

## 現病歴

7月に入り微熱で経過していたが、6/29より38.4°Cの発熱と湿性咳嗽が出現。市販の総合感冒薬を内服しても改善なく、労作時の息切れも自覚するようになり当院受診。悪寒戦慄あり。水分摂取はやや不良。

## 既往歴・生活歴

2型糖尿病 (10年) 脂質異常症 高血圧なし 喫煙：なし 飲酒：機会飲酒

## アレルギー・常用薬

薬剤アレルギー：ペニシリン系 (皮疹) / 食物：特記なし

常用薬：メトホルミン250mg 2錠 分2、ロスバスタチン2.5mg 1錠 分1、(血糖手帳持参)

## 現症・バイタル

体温 38.4°C 血圧 142/88 mmHg 脈拍 98/分 整 SpO2 94% (室内気) 呼吸数 22/分  
胸部聴診：右下肺野に coarse crackles。咽頭発赤軽度。頸部リンパ節腫脹なし。下腿浮腫なし。

## 検査

血液：WBC 11,200 / $\mu$ L、CRP 8.9 mg/dL、随時血糖 186 mg/dL、HbA1c 7.4%

画像：胸部X線正面 → 右下肺野に浸潤影。心陰影拡大なし。

## 診断

市中肺炎 (右下葉) / 基礎に2型糖尿病。誤嚥性は現時点で否定的。

## 処方・方針

Rp) レボフロキサシン錠500mg 1錠 分1 朝食後 5日分 (ペニシリンアレルギーのためニューキノロン選択)  
アセトアミノフェン錠500mg 発熱時頓用 10回分

方針：3日後（7/5）再診。呼吸困難増悪・SpO2低下時は当日受診指示。水分摂取励行、血糖自己測定を継続。

記載医：内科 村上 直人（医籍登録番号 3552841）

次回予約：令和8年7月5日 10:30

## 診療情報提供書

令和8年7月8日

みどり循環器クリニック

不整脈外来 御担当先生 御机下

東洋総合病院 循環器内科

紹介医師 長谷川 誠 (医籍登録番号 2841097)

|      |                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------|
| 患者氏名 | 佐藤 健一郎 (サトウ ケンイチロウ) 男性                                        |
| 生年月日 | 西暦1958年3月2日 (67歳)                                             |
| 住所   | 〒273-0005 千葉県船橋市本町3-4-15                                      |
| 連絡先  | 047-460-8831 / 携帯 080-5512-3390 / Mail k.sato58@example.ne.jp |
| 患者番号 | 0098765 被保険者番号 27140882 記号 018 番号 552                         |
| 傷病名  | 発作性心房細動、高血圧症、脂質異常症                                            |
| 紹介目的 | カテーテルアブレーション適応評価のため                                           |

平素より大変お世話になっております。上記患者様につきまして、下記のとおり御高診をお願い申し上げます。

3年前より動悸を自覚され、当科にて発作性心房細動と診断いたしました。ビソプロロールおよびアピキサバンによる薬物療法を継続しておりましたが、本年に入り発作頻度が増加（月2～3回、持続1～数時間）し、動悸に伴う倦怠感の訴えが強くなっております。CHADS2スコア2点。

直近の検査所見は、12誘導心電図で洞調律（発作時は心房細動波形を確認）、24時間ホルター心電図にて発作性心房細動を複数回記録、心エコー図では左房径42mm、左室駆出率58%、明らかな弁膜症は認めておりません。血液検査ではeGFR 68、肝機能正常、LDL 148mg/dLでした。

薬物療法での症状コントロールに限界があり、根治的治療としてカテーテルアブレーションの適応につき、貴院での御評価をお願いしたく紹介いたします。現在の処方は、ビソプロロール2.5mg 分1、アピキサバン5mg 分2、アムロジピン5mg 分1、ロスバスタチン5mg 分1です。抗凝固薬は継続中です。

御多忙のところ恐縮ではございますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

東洋総合病院 循環器内科 長谷川 誠

長谷川

# 診 断 書

氏名 鈴木 陽子 性別 女  
生年月日 S40.5.10 (満60歳)  
住所 神奈川県横浜市中区山下町7-8-2 パークサイド302  
患者ID 12-004587 連絡先 045-641-3300

病名

右橈骨遠位端骨折（右手関節）

受傷年月日

令和8年6月20日（自宅玄関先で転倒）

上記の者は、令和8年6月20日 当院を受診し、右橈骨遠位端骨折と診断した。徒手整復のうえギプス固定を施行し、外来にて保存的加療を継続中である。

本骨折の治療のため、令和8年6月20日から令和8年8月15日まで**およそ8週間**の加療を要する見込みである。

この間、右手を使用する作業および重量物の運搬は制限を要する。就労にあたっては軽作業（左手中心）への配慮が望ましい。

なお、経過により加療期間は変動しうる。

上記のとおり診断する。 令和8年7月3日

医療法人 みなと整形外科病院  
神奈川県横浜市中区相生町2-1-4  
TEL 045-641-3300

整形外科 担当医 大森 隆之（医籍登録番号 3120774）

大森  
之印

患者氏名 高橋 悟 (タカハシ サトル) 患者ID LAB-77120 生年月日 1972/08/15 (53歳) 性別 男  
依頼元 のぞみクリニック (内科) 依頼医 井上 洋子

| 項目            | 結果   | 単位                 | 基準値         | 判定 |
|---------------|------|--------------------|-------------|----|
| 血算            |      |                    |             |    |
| WBC           | 11.9 | $10^3/\mu\text{L}$ | 3.3-8.6     | H  |
| RBC           | 4.05 | $10^6/\mu\text{L}$ | 4.35-5.55   | L  |
| Hb            | 11.8 | g/dL               | 13.7-16.8   | L  |
| Plt           | 288  | $10^3/\mu\text{L}$ | 158-348     |    |
| 生化学           |      |                    |             |    |
| AST           | 62   | U/L                | 13-30       | H  |
| ALT           | 78   | U/L                | 10-42       | H  |
| $\gamma$ -GTP | 145  | U/L                | 13-64       | H  |
| T-Bil         | 0.9  | mg/dL              | 0.4-1.5     |    |
| BUN           | 22   | mg/dL              | 8-20        | H  |
| Cr            | 1.12 | mg/dL              | 0.65-1.07   | H  |
| eGFR          | 55.3 | mL/min             | $\geq 60$   | L  |
| Na            | 139  | mmol/L             | 138-145     |    |
| K             | 4.6  | mmol/L             | 3.6-4.8     |    |
| 脂質・代謝         |      |                    |             |    |
| LDL-C         | 172  | mg/dL              | 65-139      | H  |
| HDL-C         | 41   | mg/dL              | 40-90       |    |
| TG            | 224  | mg/dL              | 30-149      | H  |
| 随時血糖          | 168  | mg/dL              | 70-109      | H  |
| HbA1c         | 7.8  | %                  | 4.9-6.0     | H  |
| 炎症・その他        |      |                    |             |    |
| CRP           | 3.4  | mg/dL              | $\leq 0.14$ | H  |
| UA            | 7.9  | mg/dL              | 3.7-7.0     | H  |

※ H=基準値より高値、L=基準値より低値。肝機能・脂質・血糖の高値、腎機能の軽度低下を認めます。臨床所見と併せ担当医の判断をお願いします。溶血・脂肪血の影響なし。

あおぞら在宅クリニック 訪問診療記録 / 埼玉県さいたま市浦和区常盤9-2-1

患者：渡辺 くに（ワタナベ クニ） 女・昭和6年11月3日生（94歳） 患者ID：ZT-0453

住所：さいたま市浦和区岸町4-3-12 TEL 048-822-5510（長男 渡辺 隆宅） 保険者番号 13109 記号 高齢 番号 208

訪問日時：令和8年7月9日 14:20 同行：訪問看護ST みどり 主病名：慢性心不全、アルツハイマー型認知症、慢性腎臓病

## S（主観）

- ・この2～3日、夜間の息苦しさで目が覚めると同居長男より。食欲低下、下肢のむくみ増悪。
- ・本人「胸がしんどい」。会話は短文可、見当識は日時あいまい。

## O（客観）

BT 36.6 BP 148/86 P 92 不整（Af既知） SpO2 93%(RA) RR 22

両下腿に圧痕性浮腫(++)、頸静脈怒張あり。肺野下部でcoarse crackles。体重 前回48.2→49.6kg(+1.4)。  
内服アドヒアランス不良の様子（残薬多め）。

## A（評価）

慢性心不全の急性増悪（うっ血傾向）。CKDあり利尿薬調整に注意。認知症による服薬管理困難が背景。

## P（計画）

- ・フロセミド20mg→40mg 分1へ増量、3日後に体重・浮腫再評価。
- ・水分・塩分制限を長男へ再指導。服薬カレンダー導入、訪問看護で服薬確認を追加。
- ・SpO2 90%未満/起坐呼吸出現時は臨時往診または救急要請の指示。
- ・次回定期訪問：7/16。血液（BNP, 腎機能, 電解質）を臨時で提出。

記載：在宅医 桜井 大輔（医籍登録番号 4187203） / あおぞら在宅クリニック

氏名 山本 蓮（ヤマモト レン） 男児 生年月日 令和2年4月3日（6歳） 患者番号 P-3391  
保護者 山本 由美（母） 連絡先 090-3377-1245 住所 吹田市広芝町8-2-5 保険 06270135 記号 55 番号 402

18.2kg

体重

112cm

身長

38.9℃

体温

SpO2 98

経皮酸素飽和度

## 受診日 / 主訴

令和8年7月10日（再診）。昨日からの発熱（39℃台）とのどの痛み。食事量やや低下、機嫌はまずまず。咳・鼻汁は軽度。

## 経過・所見

咽頭に強い発赤と白苔付着、軟口蓋に点状紅斑。頸部リンパ節腫脹あり（圧痛+）。胸部清明、皮疹なし（莓舌軽度）。A群溶連菌迅速抗原検査 陽性。

## 診断

A群β溶血性連鎖球菌性咽頭炎（溶連菌感染症）

## 処方（体重18kg）

Rp) アモキシシリン細粒 20% 1回0.4g（力価80mg）1日3回 毎食後 **10日分**（飲みきり指導）  
カロナール細粒 発熱時・疼痛時 頓用 1回200mg 5回分  
※ 抗菌薬は解熱しても10日間内服を完遂すること。皮疹・呼吸苦出現時は中止し受診。

## 生活指導・方針

登校（登園）は抗菌薬開始後24時間かつ解熱まで見合わせ。水分摂取励行。3～4日で解熱しない場合や耳痛・関節痛出現時は再診。約2～3週後に尿検査（腎炎スクリーニング）を予定。